



Revisión

La soledad como factor de riesgo del suicidio en personas mayores de 60 años: una revisión sistemática

Noura Allaoui^a y Josep Deví^{a,b,*}

^a Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España

^b Institut de Salut Mental, Hospital del Mar – Centre Dr. Emili Mira, Barcelona, España



INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 25 de septiembre de 2024

Aceptado el 4 de noviembre de 2024

Palabras clave:

Soledad
Aislamiento social
Suicidio
Ideación suicida
Riesgo de suicidio
Vejez
Edad adulta mayor

R E S U M E N

Introducción: la esperanza de vida en la población mayor está en constante aumento, al igual que la incidencia de la soledad. Este fenómeno en esta población puede manifestarse objetiva o subjetivamente y persistir en el tiempo, aumentando el riesgo de problemas de salud física y psicológica, incluyendo la ideación suicida y su consumación.

Desarrollo: el objetivo de esta revisión sistemática ha sido analizar el impacto de la soledad, tanto objetiva como subjetiva, como factor de riesgo del suicidio en personas mayores de 60 años. Se realizaron búsquedas en las bases de datos electrónicas de PubMed, PsycInfo, Web of Science y EMBASE y se revisó la evidencia siguiendo los criterios PRISMA. De los 1.335 artículos registrados, se seleccionaron 15 que cumplieron con los criterios de inclusión.

Conclusiones: los resultados obtenidos indican que la ideación suicida en este grupo oscila entre el 5,1 y 42%, que el sentimiento de soledad fluctúa entre el 1,6 y 42,16% y que las personas que viven solas muestran una mayor propensión a la ideación suicida. La relación entre soledad y suicidio fue significativa ($p < 0,001$) en la mayoría de los estudios, identificando la soledad como un factor de riesgo. El apoyo social, una de las variables analizadas, se evidenció como un factor protector.

© 2024 Elsevier España, S.L.U. Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

Loneliness as a risk factor for suicide in people over 60 years of age: A systematic review

A B S T R A C T

Introduction: Life expectancy in the elderly population is constantly increasing, as is the incidence of loneliness. This phenomenon in this population can manifest itself objectively or subjectively and persist over time, increasing the risk of physical and psychological health problems, including suicidal ideation and its consummation.

Development: The aim of this systematic review was to analyze the impact of loneliness, both objective and subjective, as a risk factor for suicide in people over 60 years of age. The electronic databases of PubMed, PsycInfo, Web of Science and EMBASE were searched and the evidence was reviewed following the PRISMA criteria. Of the 1,335 articles registered, 15 were selected that met the inclusion criteria.

Conclusions: The results obtained indicate that suicidal ideation in this group ranges between 5.1% and 42%, that the feeling of loneliness fluctuates between 1.6% and 42.16% and that people living alone show a greater propensity to suicidal ideation. The relationship between loneliness and suicide was significant ($p < 0.001$) in most studies, identifying loneliness as a risk factor. Social support, one of the variables analyzed, was shown to be a protective factor.

© 2024 Elsevier España, S.L.U. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

Keywords:

Loneliness
Social isolation
Suicide
Suicidal ideation
Suicide risk
Old age
Older adulthood

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: josep.devi@uab.cat (J. Deví).

Introducción

Envejecimiento

La vejez, última etapa del ciclo vital, se caracteriza por cambios físicos y psicológicos que varían entre individuos y que conducen a la muerte¹. Sin embargo, los avances médicos han propiciado un aumento en la longevidad al modular o atenuar las enfermedades, disminuir la mortalidad infantil e incrementar la esperanza de vida².

En 2022, el 28,2% de la población española tenía más de 60 años, y se estima que para 2050 este porcentaje supere el 31,4% en personas mayores de 65 años, alcanzando un 11,6% en los mayores de 80^{1,3}.

Suicidio

La Organización Mundial de la Salud define el suicidio como «todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil»⁴.

Anualmente, se suicidan aproximadamente 800 mil personas en todo el mundo, ocupando una de las 10 principales causas de muerte y convirtiéndose en un problema social y de salud pública grave⁴.

En España, representa la principal causa de muerte no natural, siendo una de las primeras causas de deceso en la población mayor de 70 años^{1,5}. En 2021 se suicidaron 4.003 personas en España. De estos, el 39,7% representaban a las personas mayores de 60 años, de las cuales 29,7% eran hombres y 10% eran mujeres⁶.

Determinantes biopsicosociales del suicidio

El suicidio en personas mayores de 60 años tiene un origen multifactorial y existen diversos determinantes biopsicosociales que aumentan su riesgo⁷.

Desde una perspectiva biológica, se evidencia que los hombres muestran una mayor propensión de completar el suicidio, mientras que las mujeres presentan una inclinación más hacia los intentos suicidas. Los problemas de salud física, especialmente las enfermedades crónicas, también se han relacionado con este fenómeno¹.

Respecto a los factores psicológicos, se ha constatado que los trastornos psicopatológicos, tales como los trastornos depresivos o de ansiedad, se han relacionado con el suicidio, particularmente en ausencia de un tratamiento adecuado. Determinantes, como el sentimiento de soledad, la insatisfacción con la vida y la falta de ocupación diaria, también se han asociado con un aumento del riesgo de suicidio^{1,7}.

En cuanto a los factores sociales, se ha observado que la soledad derivada por la situación de vivir solo, la ausencia de pareja y la escasa red de apoyo social, tiene un impacto significativo en la salud de las personas mayores e incrementa el riesgo de suicidio. El duelo, los bajos niveles educativos, el desempleo, la jubilación, las dificultades económicas y las familias disfuncionales son otros factores que se han vinculado con esta variable¹.

Soledad

La soledad es un fenómeno complejo que varía entre individuos y circunstancias, pudiendo ser deseado o no deseado, así como objetivo o subjetivo⁸. La soledad deseada se experimenta de manera positiva, siendo una elección voluntaria, mientras que la no deseada se percibe negativamente y suele ser impuesta por factores externos⁹. La soledad objetiva o aislamiento social, se refiere a la ausencia de contacto e interacción con la red social, mientras que la soledad subjetiva o aislamiento emocional, se relaciona con el sentimiento de falta o pérdida de compañía⁸.

Según Chawla et al.¹⁰, aproximadamente el 28,5% de las personas mayores experimentan soledad, de las cuales el 25,9% tiene un nivel

moderado y el 7,9% un nivel grave. En España, se estima que alrededor del 22,4% de los adultos mayores reportan sentirse solos².

En esta población, este fenómeno está estrechamente vinculado con el sentimiento de soledad y con la escasa interacción con el entorno social^{8,9}. Mayoritariamente, se relaciona con la pérdida de seres queridos, la jubilación, el vacío del hogar, los problemas de salud, la institucionalización y, más recientemente, con el confinamiento de la COVID-19^{8,9}.

La soledad puede tener graves repercusiones en la salud, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares e hipertensión, así como contribuyendo al desarrollo de depresión, ansiedad y problemas cognitivos. Estos efectos reducen la calidad de vida y el bienestar emocional, y aumentan el riesgo de mortalidad⁸. Sin embargo, la satisfacción en las relaciones sociales, tanto en términos de cantidad como de calidad, ayuda a contrarrestar este fenómeno, promoviendo un sólido apoyo social y una adecuada integración de los mayores en la sociedad¹¹.

Con base en todo lo anterior, y dado el elevado porcentaje de suicidios en la población gerontológica, así como el impacto negativo que la soledad tiene en su salud, esta revisión sistemática (RS) tiene como finalidad analizar el impacto de la soledad objetiva y subjetiva, así como del apoyo social como variable secundaria, en la ideación y conducta suicida en personas mayores de 60 años.

Material y métodos

Estrategia de búsqueda y proceso de selección

La figura 1 presenta el diagrama de flujo del proceso de investigación. De los 1.335 registros identificados, 1.188 fueron excluidos por título. Tras un primer cribado de 147 artículos, 38 fueron eliminados por duplicidad y 55 por evaluación de resúmenes. Finalmente, se realizó la lectura completa de 54 y se seleccionaron 15 para la RS.

De los estudios evaluados, 30 se excluyeron por no cumplir algún criterio. Específicamente, los trabajos de Murayama et al.¹² y Wand et al.¹³ fueron descartados por tratarse de revisiones biográficas. Hansen et al.¹⁴, Tani et al.¹⁵, Runtuwene y Buster¹⁶, Bekhet y Zauszniewski¹⁷, Dong et al.¹⁸, Ebimbo et al.¹⁹, Kino et al.²⁰ y Barnow et al.²¹ se excluyeron por no abordar la relación entre la soledad y el suicidio. Lebre et al.²² y Karbeyaz et al.²³ fueron omitidos por recopilar información a través de expedientes hospitalarios o judiciales, respectivamente. Los estudios de Narishige et al.²⁴, Bennardi et al.²⁵, Barak et al.²⁶, Kobayashi y Steptoe²⁷, Prawira et al.²⁸, Pitman et al.²⁹, Rurup et al.³⁰, Rurup et al.³¹ y Aisenberg-Shafran et al.³² se excluyeron por abarcar diferentes grupos de edad. Ryu et al.³³, Fullen et al.³⁴, Alemi et al.³⁵, Van Orden et al.³⁶, Vanderhorst y McLaren³⁷, Bernier et al.³⁸ e Innamorati et al.³⁹ no fueron considerados debido a que no trataban específicamente el tema de la soledad. El estudio de Steptoe et al.⁴⁰ fue excluido por evaluar la relación entre la soledad y la mortalidad en general. El trabajo de Hernandez et al.⁴¹ fue descartado porque la mayoría de los sujetos incluidos murieron por causas naturales. Otros 9 artículos fueron omitidos por otros motivos. Cuperfain et al.⁴², Wand et al.⁴³, Silva et al.⁴⁴, Huang et al.⁴⁵, Lee et al.⁴⁶, Rubenowitz et al.⁴⁷ y Waern et al.⁴⁸ no se incluyeron debido a que adoptaban un enfoque cualitativo. Hawton y Harris⁴⁹ y Harrison et al.⁵⁰ fueron excluidos por no especificar cómo se midió la soledad.

La revisión sistemática se llevó a cabo siguiendo los criterios de la declaración *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis 2020*⁵¹. Se utilizó Mendeley como gestor documental para administrar las referencias bibliográficas.

Criterios de elegibilidad

Se priorizaron los estudios con muestras compuestas por personas mayores de 60 años, siendo esta la población de interés principal. Se incluyeron artículos que abordaban la soledad objetiva, la soledad

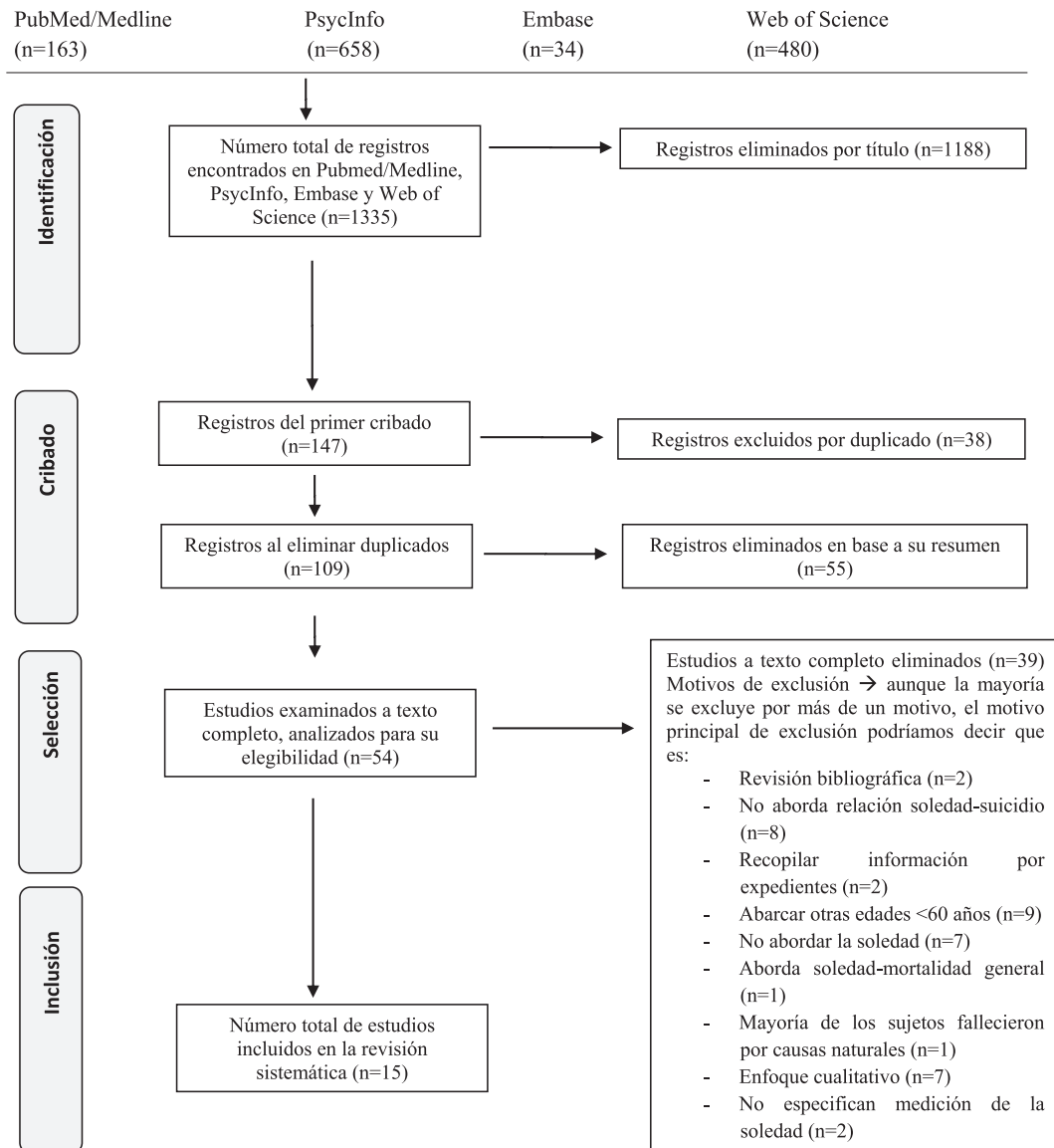


Figura 1. Procedimiento de selección de artículos para la revisión sistemática.

subjetiva y, adicionalmente, la red y apoyo social, como variables independientes. Los estudios incluidos debían analizar el impacto de la soledad y el apoyo social sobre la conducta, intento o ideación suicida, así como sobre el deseo de morir.

Los artículos seleccionados recopilan información retrospectiva, a través de heteroinformes respondidos por allegados de la víctima, o prospectiva, mediante autoinformes administrados a la población de interés.

Se incluyeron diseños de investigación de casos y controles, cohortes y transversales, y se aceptaron los idiomas castellano, catalán, inglés y francés.

Se descartaron los artículos de caso único, revisiones sistemáticas y metaanálisis, así como estudios que abordaban intervenciones sobre la soledad o el suicidio.

Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda en septiembre y octubre de 2023 en las bases de datos electrónicas PubMed, PsycInfo, Web of Science y EMBASE. Se formuló una ecuación de búsqueda específica para cada

base de datos, combinando términos de vocabulario controlado y no controlado mediante el uso de operadores booleanos.

Los términos del vocabulario controlado se recopilaron de PubMed, «Loneliness», «Social Isolation», «Suicide», «Suicide, Attempted», «Suicide, Completed», y «Aged», y de PsycInfo, «Loneliness», «Social Isolation», «Suicide», «Suicide, Attempted», «Suicide Risk», «Aged», «Older Adulthood» y «Older Age».

Los parámetros de búsqueda de las bases de datos se configuraron para abarcar el periodo comprendido entre 2000 y 2023. Cuando fue posible, se aplicaron filtros para incluir únicamente estudios con participantes de 60 años o más y para excluir revisiones sistemáticas, metaanálisis o intervenciones terapéuticas.

Evaluación del riesgo de sesgo

Tras evaluar la calidad de los estudios⁵², se pasó a evaluar el riesgo de sesgo de los estudios observacionales transversales y longitudinales mediante la *Risk Of Bias In Non-randomized Studies-of Interventions* (ROBINS-I)⁵³ y para los estudios de casos y controles se empleó la *Newcastle-Ottawa Scale* (NOS)⁵⁴ de casos y controles (tablas 1-3).

Tabla 1
Evaluación riesgo de sesgo de estudios observacionales transversales mediante el *Risk Of Bias In Non-randomized Studies-of Interventions* (ROBINS-I)

Estudios observacionales							Total
Artículo	Criterios de elección	Aleatoriedad	Medición de exposición	Medición de resultados	Control factores de confusión	Resultados de cada participante	
Lu et al. ⁵⁵	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Yang et al. ⁵⁶	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Wang et al. ⁵⁷	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Li et al. ⁵⁸	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo-Moderado	Bajo	Bajo	Bajo
Kim et al. ⁵⁹	Moderado	Moderado (conveniencia)	Bajo-Moderado	Moderado	Bajo	Bajo	Bajo
Lutzman et al. ⁶⁰	Moderado	Moderada (conveniencia)	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Cheung et al. ⁶¹	Bajo	Moderado (no aleatorizado)	Bajo	Bajo	Moderado	Bajo	Bajo
Lee ⁶²	Bajo	Moderado	Bajo	Moderado	Bajo	Bajo	Bajo
Lee et al. ⁶³	Moderado	Moderado (muestreo combinado)	Bajo	Bajo-Moderado	Bajo	Bajo	Bajo-moderado
Jonson et al. ⁶⁴	Moderado	Moderada (sistemática)	Moderado	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo-Moderado

Tabla 2
Evaluación riesgo de sesgo de estudios longitudinales mediante el *Risk Of Bias In Non-randomized Studies-of Interventions* (ROBINS-I)

Estudio longitudinal							Total
Artículo	Criterios de elección	Aleatoriedad	Medición de exposición	Medición de resultados	Control de factores de confusión	Disponibilidad de resultados de cada participante	
Stolz et al. ⁶⁵	Bajo	Bajo	Moderado	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Solomonov et al. ⁶⁶	Bajo	Moderado (no probabilístico)	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

Análisis de los datos

Se incluyeron artículos que utilizaron instrumentos de medida validados, así como estudios que elaboraron preguntas con respuestas cerradas. En los casos que fue posible, se analizó el coeficiente alfa de Cronbach (α), como una medida estandarizada, para evaluar la consistencia interna.

Para evaluar la soledad, Lu et al.⁵⁵ usaron la versión reducida (ULS-8)⁷⁰ de la *University of California Los Angeles Loneliness Scale* (UCLA-LS)⁷¹, sin proporcionar información sobre la consistencia interna. Lee⁶² administró la versión corta de 3 ítems de la UCLA-LS⁷² con un alfa de Cronbach de 0,807. Esta versión también la usaron Solomonov et al.⁶⁶, pero no especificaron la consistencia interna. Yang et al.⁵⁶ y Lutzman et al.⁶⁰ emplearon la tercera versión de la UCLA-LS⁷³ con α de 0,964 y de 0,84, respectivamente. Wang et al.⁵⁷ usaron la UCLA-LS, con α de 0,964, y la *Multidimensional Scale of Perceived Social Support* (MSPSS)⁷⁴, con α de 0,915. Li et al.⁵⁸ administraron la *Lubben Social Network Scale* (LSNS-6)⁷⁵ con α de 0,88. Lee et al.⁶³ evaluaron la soledad, con la UCLA-LS revisada (R-UCLA)⁷⁶ con un α de 0,91, y el apoyo social, con el *ENRICH Social Support Instrument* (ESSI)⁷⁷ con un α de 0,78. Zhu et al.⁶⁷ y Niu et al.⁶⁸ administraron la ULS-6⁷⁸ y la *Duke Social Support Index* (DSSI)⁷⁹, ambos instrumentos demostraron una buena confiabilidad y validez.

Para medir el suicidio, Yang et al.⁵⁶ administraron la *Beck Suicide Ideation Scale* (BSI-CV)⁸⁰, traducida por Li et al.⁸¹, con un α de 0,919. Solomonov et al.⁶⁶ emplearon el ítem 9 del *Patient Health Questionnaire* (PHQ-9)⁸². Lee et al.⁶³ midieron la ideación suicida mediante una escala

visual analógica. Lutzman et al.⁶⁰ aplicaron la *Beck Scale for Suicidal Ideation* (BSS)⁸³ con un α de 0,89. Finalmente, Zhu et al.⁶⁷ aplicaron la versión corta de la *Suicide Intent Scale* (SIS)⁸⁴, demostrando una fiabilidad y validez satisfactorias.

Resultados

Características de los estudios incluidos

Las características de los artículos analizados se presentan en la [tabla 4](#). Nueve estudios utilizaron un diseño observacional transversal, 3 emplearon un diseño de casos y controles, 2 tuvieron un enfoque longitudinal y uno fue de cohorte transversal. En cuanto a los estudios de casos y controles, tanto Zhu et al.⁶⁷ como Niu et al.⁶⁸ investigaron casos relacionados con personas fallecidas por suicidio, obteniendo información de 2 fuentes diferentes: un familiar y un allegado. Por otro lado, en el estudio de Wiktorsson et al.⁶⁹, los casos eran pacientes ingresados en salas de urgencia tras intentos de suicidio. Respecto al estudio de Jonson et al.⁶⁴, se trata de un diseño transversal con características de cohorte, ya que evaluó a personas de 85 años en 1986, 2008 y 2015.

Respecto a los instrumentos de evaluación, la UCLA-LS, en sus diferentes versiones, fue la más empleada para medir la soledad. Solomonov et al.⁶⁶ utilizaron la versión corta de la UCLA-LS⁷² únicamente en 2 de las 6 oleadas consideradas en su estudio. Además de evaluar la soledad, varios estudios también examinaron el apoyo social. En cuanto al suicidio, se utilizaron diversas herramientas para medir ideación suicida, conducta suicida, intentos de suicidio o deseo de morir.

Tabla 3
Evaluación riesgo de sesgo de estudios de casos y controles mediante la *Newcastle-Ottawa Scale* (NOS)

Casos y controles									Total
Artículo	Selección				Comparabilidad casos y controles	Exposición			
	Definición del caso	Representatividad de los casos	Selección de controles	Definición de controles		Determinación exposición	Misma metodología	Falta de respuesta	
Zhu et al. ⁶⁷	Bajo	Bajo	Bajo	Moderado	Bajo	Moderado	Bajo	No especifica	Bajo
Niu et al. ⁶⁸	Bajo	Bajo	Bajo	Moderado	Bajo	Moderado	Bajo	No especifica	Bajo
Wiktorsson et al. ⁶⁹	Bajo	Bajo	Bajo	Moderado	Bajo	Moderado	Bajo	moderado	Bajo

Tabla 4
Resumen de las características principales de los estudios incluidos en la revisión sistemática

Autores (año) y país	Diseño	Tamaño de la muestra (n)/sexo/edad muestra/%	Ideación/intento/conducta suicida o deseo de morir	Soledad/apoyo social/red social	Método estadístico	Instrumento de evaluación de riesgo de sesgo/calificación	Resultados %	Conclusiones	Limitaciones
Lu et al. (2020) China	Observacional transversal	n = 5.514 Mujeres: 3.148 (57,1) Hombres: 2.366 (42,9) Edad 60 – 69	Ítem dicotómico de Encuesta Nacional de Comorbilidad de EE. UU.	UCLA-LS (UIS-8)	SPSS 24.0, pruebas t y chi-cuadrado por género. Regresión logística binaria	ROBINS-I / Bajo	En los últimos 12 meses, un 7,7 reportaron ideación suicida, con diferencias significativas entre hombres (5,5) y mujeres (9,4). El sentimiento de soledad se asoció con la ideación suicida en ambos sexos (Odds Ratios; OR ajustado = 1,09, p<0,001). La soledad mostró una asociación estadísticamente significativa con la ideación suicida (p<0,05)	La ideación suicida fue mayor en mujeres, probablemente por su estatus social bajo en la familia, mayores responsabilidades y vulnerabilidad psicológica. Factores como el nivel educativo bajo, deudas, estrés, soledad y angustia psicológica se asociaron con ideación suicida en ambos géneros. La soledad, se correlacionó significativamente con la ideación suicida, indicando la necesidad de intervenciones específicas para prevenirla	La naturaleza transversal del estudio impide evaluar la causa y efecto de los resultados. Los datos están basados en medidas autoinformadas, susceptibles a sesgo de recuerdo, y errores de medición debido a variables medidas con una sola pregunta. La variable dependiente principal se valoró con una sola pregunta en lugar de un instrumento estandarizado, lo que puede no reflejar las diversas perspectivas sobre la ideación suicida
Yang et al. (2021) China	Observacional transversal	n = 538 Mujeres: 321 (59,67) Hombres: 217 (40,33) >60, edad media 78,13 ± 8,72	BSI-CV	UCLA-LS (versión 3)	SPSS 21.0, análisis descriptivos, correlación de Pearson	ROBINS-I / Bajo	Durante la última semana, el 32,7 informó soledad severa y 14,9 ideación suicida. Se identificó una correlación positiva entre soledad percibida e ideación suicida (r = 0,484; p<0,001). El impacto significativo de esta soledad en la ideación suicida se cuantificó con un coeficiente de regresión beta de 0,477 (IC, intervalos de confianza, 95%: 0,386-0,564)	El estudio encontró que los síntomas depresivos median la relación entre la soledad y la ideación suicida en residentes de hogares de ancianos. Además, la resiliencia actúa como un amortiguador contra estos factores de riesgo, sugiriendo que fortalecer la resiliencia podría reducir el riesgo de ideación suicida en adultos mayores	Datos recolectados de una ciudad, limitando generalización. Ausencia de escala específica para medir contextos socioeconómicos de residencias geriátricas. Uso de medidas autoinformadas susceptibles a sesgos. Empleo de 2 métodos diferentes de administración de cuestionarios. La naturaleza transversal del estudio impide examinar transiciones psicológicas y establecer relaciones causales
Wang et al. (2021) China	Observacional transversal	n = 538 Mujeres: 321 (59,67) Hombres: 217 (40,33) >60, edad media 78 ± 8,72	BSI-CV	UCLA-LS MSPSS	SPSS 21.0 y Mplus 8.3. Correlación de Spearman y control de variables. Análisis de rutas con Mplus 8.3 y SPSS Macro PROCESS. Significación p<0,05	ROBINS-I / Bajo	El 14,6 de los residentes experimentaron ideación suicida durante una semana. La soledad mostró una correlación positiva con la ideación suicida (r = 0,484; p<0,001) y negativa con el apoyo social (r = -0,230, p<0,001)	En este estudio se exploró cómo las limitaciones en las Actividades de la Vida Diaria (AVD), la soledad y la ideación suicida están relacionadas en residentes de hogares de ancianos. Se encontró que la soledad actúa como mediador entre las AVD limitadas y la ideación suicida, y que esta relación puede ser moderada por el apoyo social. A medida que las AVD se deterioran, los adultos	No se usó una escala específica para medir contextos socioeconómicos. La naturaleza transversal de los datos implica que las conclusiones sobre la causalidad pueden ser especulativas. Aunque se compararon modelos competitivos, no se pudo determinar una relación causal clara entre las variables

(Continúa)

Tabla 4 (Continuación)

Autores (año) y país	Diseño	Tamaño de la muestra (n)/sexo/edad muestra/%	Ideación/Intento/conducta suicida o deseo de morir	Soledad/apoyo social/red social	Método (análisis) estadístico	Instrumento de evaluación de riesgo de sesgo/calificación	Resultados %	Conclusiones	Limitaciones
Li et al. (2016) China	Observacional transversal	n = 15.957 Mujeres: 7.540 (47,3) Hombres: 8.417 (52,7) >60, edad media 71,52 ± 7,06	Tres ítems dicotómicos: ideas suicidas al mes, 12 meses y 5 años anteriores	LSNS-6 Un ítem dicotómico: sentimiento de soledad	Análisis descriptivos, regresiones logísticas penalizadas, corrección de Bonferroni. Alfa en 0,008	ROBINS-I / Bajo	El 5,1; 10 y 17,7 de los adultos mayores indicaron pensamientos suicidas durante el último mes, 12 meses y 5 años anteriores, respectivamente. La tasa de comportamiento suicida fue del 2,2; 3,5, y 6,3 para el último mes, 12 meses y 5 años anteriores, respectivamente. El 27,9 reportaron sentirse solos. La edad más joven (OR = 0,96, p<0,008) y la soledad (OR = 2,41, p<0,001) se asociaron con mayor riesgo de pensamientos suicidas durante el último año. La soledad y una red social escasa se asociaron con pensamientos suicidas durante los últimos 5 años. La soledad, también, se relacionó con los pensamientos de suicidio durante los 12 meses anteriores	mayores tienden a experimentar mayor soledad, lo cual se asocia con un aumento en la ideación suicida. El apoyo social adecuado puede atenuar los efectos negativos El estudio examinó la prevalencia de pensamientos e intentos suicidas en adultos mayores en China continental, identificando factores personales, interpersonales y ambientales relacionados. Los resultados mostraron que factores personales como la depresión, tensión financiera y limitaciones funcionales estuvieron asociados con estos comportamientos suicidas. A nivel interpersonal, la soledad y la piedad filial influyeron significativamente en los pensamientos e intentos suicidas. A nivel ambiental, vivir en comunidades rurales o urbanas mostraron ser importantes en la predicción de estos comportamientos suicidas	Utilizó datos secundarios de una encuesta original que no incluyó información sobre rasgos de personalidad, habilidades de afrontamiento y trastornos mentales, factores que pueden influir en los pensamientos e intentos suicidas. La información recopilada fue retrospectiva y autoinformada, lo que puede estar afectado por el estigma y fallos en la memoria, sin validación de registros médicos. El estudio fue transversal, impidiendo capturar cambios en las variables a lo largo del tiempo y limitando la capacidad de establecer relaciones causales. Así pues, las relaciones observadas son solo correlacionales
Kim et al. (2023) Corea del Sur	Observacional transversal	n = 650 Mujeres: 506 (77,8) Hombres: 144 (22,2) >65, edad media 78,54 ± 6,71	Un ítem dicotómico: ideación suicida durante último año	Escala de redes sociales de la Encuesta de vida de personas mayores 2017, Corea del Sur. Un ítem: sentimiento de soledad último mes	SPSS 26.0, R 4.1.0 y algoritmos de aprendizaje automático. Regresión logística, evaluada con curvas ROC y métricas	ROBINS-I / Bajo	El 26,6 experimentaron ideación suicida. El árbol de decisión identificó que la depresión (p<0,001) y el dolor (p = 0,010) eran los principales predictores de ideación suicida. La regresión logística señaló que solo la depresión mostró un aumento significativo en la ideación suicida (OR = 1,26 [IC 95%: 1,17-1,35]), mientras que la soledad (OR = 1,06 [IC 95%]) presentó una asociación más débil. El bosque aleatorizado	El estudio investigó la predicción de ideación suicida en adultos mayores sanos que viven en áreas rurales. Los resultados mostraron que la depresión es el factor más influyente en la predicción de ideación suicida, aunque otros factores como el dolor, la edad y la soledad también fueron significativos según el modelo de bosque aleatorizado. Esto contrasta con estudios previos que sugieren que la edad reduce las probabilidades de ideación suicida, destacando	El tamaño relativamente pequeño de la muestra de adultos mayores sanos en áreas rurales limita la generalización de los hallazgos de este estudio. A pesar de utilizar métodos de aprendizaje automático como el bosque aleatorizado, que puede mitigar problemas estadísticos como el sobreajuste, no se abordaron variables importantes como el consumo de alcohol o el tabaquismo, lo cual podría influir en los resultados. La medida de la carga percibida, aunque relevante

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Continúa)

Tabla 4 (Continuación)

Autores (año) y país	Diseño	Tamaño de la muestra (n)/sexo/edad muestra/%	Ideación/intento/conducta suicida o deseo de morir	Soledad/apoyo social/red social	Método (análisis) estadístico	Instrumento de evaluación de riesgo de sesgo/calificación	Resultados %	Conclusiones	Limitaciones
Lutzman et al. (2021) Israel	Observacional transversal	n = 198 hombres > 65, edad media 76,14 ± 8,05	BSS	UCLA-LS (versión 3)	SPSS v.24. Correlaciones, método PROCESS y bootstrapping	ROBINS-I / Bajo	El 42 de la muestra informó algún nivel de ideación suicida (BSS>0). En la matriz de correlaciones, la soledad se relacionó con la ideación suicida (p<0.01). La soledad mostró una mediación significativa en la relación con la ideación suicida, sobre todo, entre participantes solteros, divorciados y viudos (p<0,05)	El estudio investiga cómo la soledad y la integración social afectan la relación entre el dolor físico y la ideación suicida en hombres mayores, tanto solteros como casados. Se encontró que la soledad y la falta de mediadores significativos en esta conexión, especialmente notable en hombres solteros. El dolor físico puede intensificar el sentimiento de soledad y reducir la integración social, aumentando así el riesgo de ideación suicida en hombres mayores. Ser soltero se identifica como un factor de riesgo adicional, exacerbado en la vejez por la falta de apoyo interpersonal tras la pérdida de un conyuge, lo que aumenta la carga emocional asociada al dolor físico	escala de depresión MADRS y pertenecer a la cohorte de 1986 se asociaron con mayores probabilidades de ideación suicida. Las mujeres que se sentían solas y los hombres sin pareja mostraron una mayor propensión a la ideación suicida pasiva y activa. La ideación suicida no se asoció con la multimorbilidad, pero sí con la percepción subjetiva de mala salud
Zhu et al. (2021) China	Casos y controles 1:1	n = 484 Casos-Mujeres: 107 (44.2); Hombres: 135 (55.8) Controles-Mujeres: 107 (44.2); Hombres: 135 (55.8) >60, edad media de 73-75	SIS Autopsia psicológica	UCLA-LS (UCLA-6) DSSI	SPSS (v.20.0). Pruebas Z y t, de Kolmogorov-Smirnov para variables continuas y chi-cuadrado para categóricas. Regresión logística binaria, regresión condicional.	NOS / Bajo	En los casos de suicidio, en comparación con los controles vivos, se observó mayor propensión a experimentar soledad y carencia de apoyo social (p<0,001)	El estudio reveló que los métodos no violentos de suicidio fueron más frecuentes que los métodos violentos. Los principales factores de riesgo identificados fueron la gravedad de los síntomas depresivos para ambos tipos de suicidio y la desesperanza.	La autopsia psicológica realizada puede presentar deficiencias debido a la posible influencia del estado mental y la relación personal de los informantes con el fallecido, lo que podría resultar en errores de información y sesgos. Las herramientas utilizadas para recopilar datos no fueron validadas para informantes,

Niu et al. (2020) China	Casos y controles 1:1	n = 484 Casos-Mujeres: 106 (43,8); Hombres: 136 (56,2) Controles -Mujeres: 106 (43,8); Hombres: 136 (56,2) >60, edad media casos mujeres 74,4 ± 8,2; edad media controles mujeres 74,1 ± 8,2	Autopsia psicológica	UCLA-LS (UIS- 6) DSSI	SPSS v.23.0. Análisis descriptivos, pruebas t y Wilcoxon. Detección automática CHAID y regresión logística multivariable. Significación $p<0,05$	NOS / Bajo	El resultado de la regresión logística multivariable demostró que vivir solo (OR = 2,176 [IC 95%: 1,113- 4,254]); tener niveles más bajos de apoyo social (OR = 2,185 [IC 95%: 1,243- 3,843]) y sentirse solo y desesperado (OR = 2,446 [IC 95%: 1,089-5,492]) se asociaban con un riesgo elevado de suicidio. Los casos de suicidio informaron niveles más altos de soledad y más bajos de apoyo social ($p<0,01$)	El estudio encontró que la desesperanza y la soledad tienen una interacción significativa que aumenta el riesgo de suicidio entre los adultos mayores en zonas rurales de China, aunque la soledad por sí sola no mostró un efecto independiente. La desesperanza tuvo el mayor impacto en el suicidio. La depresión también fue un factor de riesgo importante, especialmente entre aquellos con niveles bajos de desesperanza. Además, el apoyo social subjetivo se identificó como un factor protector, mientras que vivir solo y el desempleo se asociaron independientemente con un mayor riesgo de suicidio	específicamente para los métodos no violentos. Factores sociales como la soledad, la falta de apoyo social y múltiples eventos vitales estresantes también se asociaron con un mayor riesgo de suicidio	sino para individuos que se suicidaron, lo que podría comprometer la precisión de los datos obtenidos. Aunque se utilizaron datos documentados previos y evaluaciones psiquiátricas <i>post hoc</i> para mitigar estas limitaciones, la validez de este enfoque para todas las variables utilizadas no está completamente confirmada La Autopsia Psicológica es un método que tiene limitaciones metodológicas, especialmente en la validez de los datos proporcionados por informantes cercanos en relación con las propias experiencias internas
Wiktorsson et al. (2010) Suecia	Casos y controles 1:4	n = 511 Casos - Mujeres: 57 (55); Hombres: 46 (45) Controles = 408 >70, edad media casos 79,7 ± 5,3	CPRS	Un ítem dicotómico: soledad percibida Un ítem dicotómico: vivir solo	SPSS versión 15.0. Prueba de chi- cuadrado y prueba t. Regresión logística condicional	NOS / Bajo	El 60 de los que intentaron suicidarse reportaron sentirse solos. En contraste, el 17,6 del grupo de comparación experimentaron sentimientos de soledad. Se identificó un mayor riesgo de sentirse solo en el grupo de intentos de suicidio (OR = 7,07; [IC 95%: 4,2-12,0]). La asociación entre intentos de suicidio y soledad se mantuvo significativa incluso después de ajustar por depresión (OR ajustado = 2,8 [IC del 95%: 1,3-6,1])	La selección en entorno hospitalario puede no representar a todos los ancianos que intentan suicidarse. La subestimación de la depresión en el grupo de control y la evaluación diferencial temporal introducen sesgos potenciales. El recuerdo retrospectivo y el intervalo desde el intento hasta la entrevista pueden afectar la precisión de los datos. Los Tamaños pequeños de muestra en subgrupos limitan la fiabilidad y generalización de los resultados. La exclusión de personas con demencia severa puede haber subestimado la relación entre demencia y suicidio.	La selección en entorno hospitalario puede no representar a todos los ancianos que intentan suicidarse. La subestimación de la depresión en el grupo de control y la evaluación diferencial temporal introducen sesgos potenciales. El recuerdo retrospectivo y el intervalo desde el intento hasta la entrevista pueden afectar la precisión de los datos. Los Tamaños pequeños de muestra en subgrupos limitan la fiabilidad y generalización de los resultados. La exclusión de personas con demencia severa puede haber subestimado la relación entre demencia y suicidio.	

(Continúa)

(Continúa)

Tabla 4 (Continuación)

Autores (año) y país	Diseño	Tamaño de la muestra (n)/sexo/edad muestra/%	Ideación/intento/conducta suicida o deseo de morir	Soledad/apoyo social/red social	Método (análisis) estadístico	Instrumento de evaluación de riesgo de sesgo/calificación	Resultados %	Conclusiones	Limitaciones
Stolz et al. (2016) Europa	Estudio de panel longitudinal prospectivo	n = 6.791 Mujeres: 3.913 (57,6) Hombres: 2.878 (42,4) > 70, edad media 80,5 ± 4,49	Ítem dicotómico de la escala EURO-D	Un ítem dicotómico: soledad percibida Un ítem: cambios en el estado de soledad entre olas Un ítem: tamaño de red social y estado de pareja	Análisis de datos con R (v3.2.2). Modelos de regresión logística, imputación múltiple y regresión logística multinivel bayesiana	ROBINS-1 / Bajo	Las personas que se sintieron frecuentemente solas (> 85) o experimentaron mayor soledad (> 54), mostraron más riesgo de ideación suicida pasiva y menor probabilidad de superarla	de abordar este factor en los esfuerzos de prevención del suicidio entre los ancianos	La transferibilidad de los resultados a otras culturas y contextos puede ser limitada, requiriendo estudios adicionales para validarlos. La ideación suicida pasiva se evaluó utilizando un solo ítem de una escala de depresión, lo cual podría no captar completamente la complejidad del fenómeno y la distinción entre ideación suicida pasiva y activa. Los datos de panel de SHARE pueden estar sesgados hacia una selección de salud más positiva, lo que podría haber subestimado la prevalencia de la ideación suicida pasiva. Debido al número limitado de países participantes en SHARE, las variables a nivel de país se agregaron de manera individual, lo que impidió un control estadístico más completo de los indicadores a nivel nacional
Cheung et al. (2017) Nueva Zelanda	Observacional transversal	n = 35.734 Mujeres: 21.691 (60,7) Hombres: 14.043 (39,3) Edad 65 – 109	Ítem de interRAI: deseos de muerte	Un ítem de interRAI: vivir solo Un ítem de interRAI: soledad percibida	SPSS v22. Estadísticas descriptivas, análisis bivariado con chi-cuadrado y regresión logística jerárquica de 3 pasos	ROBINS-1 / Bajo	El 9,5 presentaban deseo de muerte. La soledad se consideró un factor de riesgo del suicidio (OR = 2,40 [IC 95%:2,20-2,63])	El estudio identifica que los deseos de morir están significativamente asociados con varios factores, incluyendo la mala salud física (autopercepción de mala salud, caídas recurrentes, fatiga severa y control inadecuado del dolor), factores psicológicos (depresión, grandes estresores y ansiedad), factores sociales (soledad y disminución de actividades sociales), y deterioro cognitivo. Específicamente, la depresión, la soledad y la autopercepción de mala salud mostraron las mayores razones de probabilidad en este contexto	El estudio utiliza una muestra clínica, lo que impide generalizar los hallazgos a la población general. El ítem del interRAI sobre «Hizo declaraciones negativas» incluye una variedad de respuestas. Esta heterogeneidad afecta la interpretación de los hallazgos. El ítem de evaluación del interRAI sobre declaraciones negativas es transversal y se refiere típicamente a los últimos 3 días. Los resultados pueden variar si la evaluación se realiza en otro momento. Los evaluadores utilizan toda la información clínica disponible, pero no una entrevista diagnóstica estructurada o una escala de calificación validada

Lee (2021) Europa	Observacional transversal	n = 4.378 Mujeres: 2.522 (57,6) Hombres: 1.856 (42,4) > 65, edad media 74,82 ± 7,33	Un ítem: sentimiento suicida o deseo de estar muerto durante último mes	Versión corta de la UCLA-LS	SPSS 20.0. Análisis descriptivos y ANOVA, regresión logística binaria y ponderaciones individualizadas	ROBINS-1 / Bajo	El 6,5 informaron ideación suicida pasiva. La ideación suicida pasiva fue más prevalente en mujeres (70) que en hombres (30). La relación entre soledad y suicidio fue estadísticamente significativa (OR = 1,063 [IC 95%: 1,059-1,067], p= 0,000)	El estudio encontró que la ideación suicida pasiva es más común en los países occidentales comparado con las naciones del sur y del este de Europa. Entre los factores de riesgo, se destacó una mayor incidencia en mujeres, debido a diferencias en la expresión emocional y la tendencia a reportar sentimientos negativos. La ideación suicida pasiva fue más prevalente en el grupo de 60-75 años y varía según el estado civil, tamaño del hogar, y área de residencia, siendo más común en áreas rurales. La mala salud física, condiciones crónicas y dolor aumentan la probabilidad de ideación suicida, al igual que la depresión y la soledad. Además, una menor satisfacción con la vida y una red social más pequeña también están asociadas con mayores probabilidades de ideación suicida pasiva	Las limitaciones del estudio incluyen el diseño transversal, que no permite establecer causalidad entre variables. El uso de medidas auto-reportadas puede aumentar el sesgo de respuesta. La medida de ideación suicida pasiva es insuficiente para capturar su frecuencia y gravedad. No se proporciona información sobre la ideación suicida activa o intentos previos. El modelo de regresión no considera efectos de interacción entre variables demográficas, psicosociales y de salud. Hay una explicación limitada sobre los resultados opuestos encontrados entre la satisfacción con la vida y la calidad de vida medida por CAPS-19
Lee et al. (2021) Corea del Sur	Observacional transversal	n = 1.030 Mujeres: 800 (77,7) Hombres: 230 (22,3) Edad 65 – 97	Escala visual analógica	UCLA-LS (UCLA-R) ESSI	Mplus 7.4. Análisis de Perfil Latente (LPA), ANOVA y bivariados	ROBINS-1 / Bajo - Moderado	Todos los participantes vivían en soledad. El grupo más numeroso, el «perfil 2» (64,3) se caracterizó por niveles más bajos de depresión, ideación suicida, soledad y disfunción cognitiva, y niveles más elevados de apoyo social	El estudio examinó perfiles de riesgo psicosocial entre adultos mayores solitarios en Corea. Se identificaron tres perfiles: alta disfunción cognitiva/soledad/bajo apoyo social, bajo riesgo psicológico/alto apoyo social, y alta depresión/ideación suicida. Factores de riesgo destacados incluyen la soledad y el bajo apoyo social, asociados con disfunción cognitiva y aumento del riesgo de suicidio. También se observó que la depresión y el estado nutricional deficiente aumentan la ideación suicida. La fragilidad fue mayor en perfiles con riesgos psicosociales elevados, sugiriendo la necesidad de intervenciones psicosociales para abordar estos factores entre adultos mayores solitarios	Al ser un estudio transversal proporciona solo una visión instantánea de los perfiles de riesgo psicosocial. El uso de autoinformes en la evaluación psicosocial puede llevar a sesgos. Las limitaciones del Mini-Mental State Examination en adultos mayores con deterioro cognitivo podrían afectar la precisión de los resultados. Los perfiles identificados mediante Análisis de Perfiles Latentes podrían carecer de relevancia clínica directa. La asignación probabilística de perfiles puede interferir en la interpretación de los resultados. La muestra no fue seleccionada al azar y puede no ser representativa de todos los adultos mayores solitarios en Corea del Sur

BSI-CV: Beck Suicide Ideation Scale; BSS: Beck Scale for Suicidal Ideation; DSSI: Duke Social Support Index, Comprehensive Psychopathological Rating Scale⁴⁶; EURO-D Scale: Escala Europea de depresión⁴⁷; ESSI: ENRICH Social Support Instrument; InterRAI: InterRAI Home Care Assessment; LSNS-6: Lubben Social Network Scale; MSPSS: Multidimensional Scale of Perceived Social Support; PHQ-9: Patient Health Questionnaire; Paykel Suicide Scale⁴⁸; SIS: Suicide Intent Scale; UCLA-LS: University of California Los Angeles Loneliness Scale.

En términos de evaluación, los 15 estudios mostraron una calidad satisfactoria al cumplir con la mayoría de los criterios establecidos por la STROBE, y la mayoría de ellos demostraron un bajo riesgo de sesgo.

Los artículos incluidos en la revisión abarcaron 90.064 participantes, 51.872 eran mujeres y 37.784 eran hombres. En el estudio de Wiktorsson et al.⁶⁹, el sexo de 408 personas no fue especificado. La edad de los participantes oscilaba entre los 60 y los 109 años. La mayoría de estos estudios se centraron en investigar los factores de riesgo del suicidio en personas de edad avanzada, siendo la soledad y el apoyo social variables asociadas a este fenómeno.

De los estudios incluidos, se extrae que la prevalencia de ideación suicida, en la población de personas mayores, oscila entre un 5,1%, según la investigación de Li et al.⁵⁸, y un 42%, según el estudio de Lutzman et al.⁶⁰.

En relación con la soledad, se observó que el sentimiento de soledad fluctuaba entre el 1,6⁶⁶ y el 42,16%⁶³. En el estudio de Kim et al.⁵⁹, se observó que, entre los 477 participantes sin ideación suicida, el 2,93% reportaron sentirse solos, mientras que, en el grupo de 173 personas con ideación suicida, el porcentaje aumentó ligeramente al 3,18%. En el estudio de Solomonov et al.⁶⁶, se encontró que el 1,6% de los participantes sin ideación suicida experimentaban soledad, en comparación con el 2% en el grupo con ideación suicida. Jonson et al.⁶⁴ observaron que el porcentaje de participantes que vivían solos fue del 65,5% en 1986, del 63,1% en 2008 y del 65% en 2015. Además, detectaron que el 8,4% de los participantes en 1986, el 8,2% en 2008 y el 6,3% en 2015, experimentaban sentimientos de soledad. Niu et al.⁶⁸ encontraron que el 26% de los casos de suicidio vivían solos, en contraste con el 14,5% de los controles vivos que residían en una vivienda unipersonal. Wiktorsson et al.⁶⁹ observaron que el 64,1% de los casos vivían solos, mientras que esta cifra fue del 50% en el grupo control. Cheung et al.⁶¹ identificaron que el 45,2% de individuos con ideación suicida vivían solos, mientras que el 45,6% de los que no tenían ideación suicida también lo hacían. Además, el 38,6% de los que tenían ideación suicida reportaron sentimientos de soledad, en comparación con el 17,3% del grupo control.

Todos los estudios coincidieron en que la soledad ejerce un impacto significativo en el suicidio entre los adultos mayores. No obstante, a pesar de que se haya evidenciado el impacto considerable de la soledad en la ideación suicida, investigaciones como las de Kim et al.⁵⁹ y Jonson et al.⁶⁴ observaron que otras variables, como la depresión geriátrica y el dolor, son los predictores más significativos de la ideación suicida, destacando su relevancia sobre la soledad. En contraposición, Wiktorsson et al.⁶⁹ demostraron que la relación entre soledad e intentos de suicidio seguía siendo significativa, incluso después de ajustar la razón de probabilidades por depresión.

Respecto al aislamiento social, son escasos los estudios que la analizaron. Sin embargo, aquellos que la abordaron, identificaron que una red social escasa y vivir solo se asociaban significativamente con el suicidio^{58,68}. En contraposición, Solomonov et al.⁶⁶ observaron que vivir en un hogar con 2 o más personas incrementaba la probabilidad de experimentar pensamientos suicidas.

Otros estudios incluidos en esta revisión también exploraron la influencia del apoyo social sobre el suicidio. Wang et al.⁵⁷ identificaron una asociación negativa entre el apoyo social y la ideación suicida. En concordancia, Zhu et al.⁶⁷ y Niu et al.⁶⁸ encontraron que los casos de suicidio, en comparación con los controles vivos, presentaban un menor apoyo social y experimentaban mayores niveles de soledad. Además, Lee et al.⁶³ resaltaron que un perfil caracterizado por bajos niveles de soledad y altos niveles de apoyo social reducía el riesgo de suicidio.

Finalmente, es importante señalar que, entre los estudios revisados, son escasos los que han realizado un análisis estratificado para examinar el impacto de la soledad y el suicidio según el género. De los que lo hicieron, se centraron en la diferencia en la ideación suicida, concluyendo que esta era mayor en mujeres que en hombres^{55,62}.

Discusión

Numerosos estudios han abordado los factores de riesgo asociados al suicidio en la población de personas mayores. Investigaciones como las de Lee⁶², Lee et al.⁶³, Li et al.⁵⁸, Stolz et al.⁶⁵, Solomonov et al.⁶⁶ y Wiktorsson et al.⁶⁹ han contribuido significativamente a este campo. Sin embargo, el estudio específico sobre el papel predictor de la soledad en el suicidio es limitada, como lo demuestran los estudios de Yang et al.⁵⁶, Lutzman et al.⁶⁰, Niu et al.⁶⁸ y Wang et al.⁵⁷. Asimismo, las revisiones sistemáticas que exploran la relación entre la soledad y el suicidio en personas mayores son escasas, y aquellas que existen, como la de McClelland et al.⁸⁶, se centran en la población general.

Por ello, el propósito de esta investigación fue analizar la literatura científica para determinar cómo la soledad, considerando el apoyo social como una variable secundaria, incide en el riesgo de suicidio en personas mayores de 60 años.

Los hallazgos obtenidos indican que hay una asociación positiva entre la soledad y el riesgo de suicidio, ya sea en términos de ideación suicida^{55-58,60,63-66}, deseo de muerte⁶¹, intentos autolíticos⁶⁹ o suicidio consumado^{67,68}. Contrariamente, el apoyo social emerge como un factor atenuante de la soledad, además de ejercer un papel protector con una relación inversamente significativa con el riesgo de suicidio^{57,63,66-68}.

Estos resultados concuerdan con diversas teorías. La teoría interpersonal de Van Orden et al.⁸⁷ concluye que dimensiones de la conexión social, como la soledad, pueden anticipar comportamientos suicidas letales. Esta teoría sostiene que estas variables están relacionadas con el suicidio porque actúan como indicadores de que una necesidad psicológica, descrita por Baumeister y Leary⁸⁸ como la «necesidad de pertenecer», no se satisface, lo que aumenta el riesgo de desarrollar deseos de muerte. Otras teorías, como la de Durkheim⁸⁹ o la de O'Connor y Kirtley⁹⁰⁻⁹², también han propuesto el papel crucial que desempeñan la conexión y el apoyo social, respectivamente, sobre el suicidio.

Sin embargo, es fundamental señalar que, según lo evidenciado en varios estudios, la soledad y la falta de apoyo social no son los únicos determinantes asociados al suicidio. Otras variables biopsicosociales como la depresión^{64,69}, el dolor⁵⁹ y la desesperanza⁶⁸ también han demostrado tener un impacto significativo.

A pesar de estas consideraciones, esta revisión concluye que tanto la percepción como la realidad de la soledad, junto con la falta de apoyo social, deben considerarse factores de riesgo del suicidio en la población estudiada. Esta conclusión destaca la importancia de tener en cuenta los resultados obtenidos, dado el aumento de la esperanza de vida y el consecuente incremento de la soledad en este grupo demográfico^{1,2}. Por ello, se subraya la importancia de una evaluación temprana de la soledad para identificar situaciones de riesgo y mitigar sus efectos en esta cohorte².

Las fortalezas de este estudio se evidencian principalmente en la inclusión y síntesis de la información proveniente de diversos estudios realizados en distintos países. Este enfoque ha dado como resultado un aumento del tamaño de la muestra, lo que ha facilitado un análisis más consistente de los resultados⁹¹. Asimismo, la adopción de un enfoque de revisión sistemática ha permitido una exploración exhaustiva de la relevancia de la soledad como factor de riesgo del suicidio, así como la destacada importancia de desarrollar e implementar programas destinados a contrarrestar las repercusiones de este fenómeno en la población mayor de 60 años⁸.

Las limitaciones identificadas en este trabajo derivan de la heterogeneidad de los artículos incluidos, lo que podría haber afectado a la integración de los resultados. En cuanto al diseño del estudio, se han incluido desde diseños observacionales hasta diseños longitudinales. Asimismo, la variabilidad en el tamaño de la muestra es notable, algunos estudios presentan muestras reducidas y otras más amplias. Además, a pesar de que la población estudiada son personas mayores de 60 años, la edad de los participantes difiere considerablemente, algunos estudios incluyen adultos de 60 años o

más, mientras que otros se centran en mayores de 65, mayores de 70, entre otras categorías. Respecto a los instrumentos de medición, se ha observado el uso de diferentes herramientas para evaluar las variables objeto de estudio. Por otro lado, la ubicación geográfica de los estudios también contribuye a la variabilidad, dado que las diferencias culturales y contextuales pueden influir en la interpretación de los resultados. Por último, el año en el que se llevó a cabo cada investigación también puede haber contribuido a la heterogeneidad, debido a los cambios temporales en la sociedad, influenciados por factores como los avances médicos.

Las futuras líneas de investigación que podrían tener un impacto positivo en esta población abarcan diversas áreas: la exploración del impacto de la soledad deseada y no deseada en el riesgo de suicidio para comprender integralmente su influencia en la salud de esta población; la investigación de la relación entre soledad y suicidio desde una perspectiva de género, considerando las diferencias existentes; el desarrollo de herramientas adaptadas a la en la población diana para detectar tempranamente la soledad y el riesgo de suicidio; la creación de programas de integración social para personas mayores; así como el estudio del impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la mitigación de la soledad y del suicidio.

Conclusión

La investigación específica sobre la soledad como factor de riesgo del suicidio es escasa. Los estudios disponibles sugieren una asociación positiva entre la soledad y el riesgo de suicidio en personas mayores, mientras que el apoyo social actúa como un factor protector. Estos hallazgos destacan la importancia de considerar la percepción como la presencia real de la soledad, así como el nivel de apoyo social, para detectar de manera temprana situaciones de riesgo en la población estudiada con el fin de aplicar intervenciones eficaces.

Appendix A. Dato suplementario

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.psqi.2024.100530>.

Bibliografía

- Calderón-Cholbi A, Mateu-Mollá J, Lacomba-Trejo L. Factores de riesgo y protección del suicidio en personas mayores: una revisión sistemática. *Inform Psicol*. 2021;121:85–105.
- Palma-Ayllón E, Escarabajal-Arrieta MD. Efectos de la soledad en la salud de las personas mayores. *Gerokomos*. 2021;32(1):22–5.
- Instituto Nacional de Estadística (INE). Población Residente por Fecha, Sexo y Edad. [consultado 25 Nov 2022]. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9663>; 2022.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). Suicidio. [consultado 13 Ene 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide>; 2023.
- Instituto Nacional de Estadística (INE). Defunciones por Causas. [consultado 27 Nov 2018]. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=7947>; 2018.
- Instituto Nacional de Estadística (INE). Defunciones por suicidios. [consultado 8 Mar 2021]. Disponible en: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?tpx=29992&L=0>; 2021.
- Valera Ortín J, Lucerón Lucas-Torres MI. Factores relacionados con el suicidio en personas mayores: una revisión sistemática [Suicide related factors in the elderly: a systematic review]. *Rev Esp Salud Publ*. 2021;95, e202110166 Español.
- Bermeja AI, Ausín B. Programas para combatir la soledad en las personas mayores en el ámbito institucionalizado: una revisión de la literatura científica [Programs to combat loneliness in the institutionalised elderly: a review of the scientific literature]. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2018;53(3):155–64.
- Tirado RY. La soledad no deseada en el ámbito de la gerontología. *Trabajo Soc Hoy*. 2019;88:25–42.
- Chawla K, Kunonga TP, Stow D, Barker R, Craig D, Hanratty B. Prevalence of loneliness amongst older people in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2021;16(7), e0255088.
- Gallardo-Peralta LP, Sánchez-Moreno E, Rodríguez Rodríguez V, García Martín M. La investigación sobre soledad y redes de apoyo social en las personas mayores: una revisión sistemática en Europa [Studying loneliness and social support networks among older people: a systematic review in Europe]. *Rev Esp Salud Publ*. 2023;97, e202301006.
- Murayama H, Shibui Y, Fukuda Y, Murashima S. A new crisis in Japan-social isolation in old age. *J Am Geriatr Soc*. 2011;59(11):2160–2.
- Wand APF, Zhong BL, Chiu HFK, Draper B, De Leo D. COVID-19: the implications for suicide in older adults. *Int Psychogeriatr*. 2020;32(10):1225–30.
- Hansen T, Sevenius Nilsen T, Knapstad M, Skirbekk V, Skogen J, Vedaa Ø, et al. Covid-fatigued? A longitudinal study of Norwegian older adults' psychosocial well-being before and during early and later stages of the COVID-19 pandemic. *Eur J Ageing*. 2021;19(3):463–73.
- Tani M, Cheng Z, Piracha M, Wang BZ. Ageing, health, loneliness and wellbeing. *Soc Indic Res*. 2022;160(2):791–807.
- Runtuwene NF, Buster MCA. Domestic-setting corpses, an urban problem? *J Forensic Leg Med*. 2019;61:22–6.
- Bekhet AK, Zauszniewski JA. Mental health of elders in retirement communities: is loneliness a key factor? *Arch Psychiatr Nurs*. 2012;26(3):214–24.
- Dong X, Chang ES, Wong E, Simon M. Perception and negative effect of loneliness in a Chicago Chinese population of older adults. *Arch Gerontol Geriatr*. 2012;54(1):151–9.
- Ebimbo SO, Atama CS, Onalu CE, Obasi-Igwe IA, Aghedo GU. Predictors of loneliness among older adults in south-eastern Nigeria: implications for social workers. *Eur J Ment Health*. 2021;16(1):3–19.
- Kino S, Stickley A, Arakawa Y, Saito M, Saito T, Kondo N. Social isolation, loneliness, and their correlates in older Japanese adults. *Psychogeriatrics*. 2023;23(3):475–86.
- Barnow S, Linden M, Freyberger HJ. The relation between suicidal feelings and mental disorders in the elderly: results from the Berlin Aging Study (BASE). *Psychol Med*. 2004;34(4):741–6.
- Lebret S, Perret-Vaille E, Mulliez A, Gerbaud L, Jalenques I. Elderly suicide attempters: characteristics and outcome. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2006;21(11):1052–9.
- Karbeyaz K, Çelikel A, Emiral E, Emiral GÖ. Elderly suicide in Eskisehir. *Turk J Forensic Leg Med*. 2017;52:12–5.
- Narishige R, Kawashima Y, Otaka Y, Saito T, Okubo Y. Gender differences in suicide attempters: a retrospective study of precipitating factors for suicide attempts at a critical emergency unit in Japan. *BMC Psychiatry*. 2014(14):144.
- Bennardi M, Caballero FF, Miret M, Ayuso-Mateos JL, Haro JM, Lara E, et al. Longitudinal relationships between positive affect, loneliness, and suicide ideation: age-specific factors in a general population. *Suicide Life Threat Behav*. 2019;49(1):90–103.
- Barak Y, Cheung G, Fortune S, Glue P. No country for older men: ageing male suicide in New Zealand. *Australas Psychiatr*. 2020;28(4):383–5.
- Kobayashi LC, Steptoe A. Social isolation, loneliness, and health behaviors at older ages: longitudinal cohort study. *Ann Behav Med*. 2018;52(7):582–93.
- Prawira B, Liem A, Yulianto JE, Han J. The associated factors of self-harm and suicide ideation among Chinese Indonesians during the COVID-19 pandemic. *Int Perspect Psychol*. 2023;12(2):85–95.
- Pitman AL, King MB, Marston L, Osborn DPJ. The association of loneliness after sudden bereavement with risk of suicide attempt: a nationwide survey of bereaved adults. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 2020;55(8):1081–92.
- Rurup ML, Deeg DJ, Poppelaars JL, Kerkhof AJ, Onwuteaka-Philipsen BD. Wishes to die in older people: a quantitative study of prevalence and associated factors. *Crisis*. 2011;32(4):194–203.
- Rurup ML, Pasman HR, Goedhart J, Deeg DJ, Kerkhof AJ, Onwuteaka-Philipsen BD. Understanding why older people develop a wish to die: a qualitative interview study. *Crisis*. 2011;32(4):204–16.
- Aisenberg-Shafran D, Bar-Tur L, Levi-Belz Y. Who is really at risk? The contribution of death anxiety in suicide risk and loneliness among older adults during the COVID-19 pandemic. *Death Stud*. 2022;46(10):2517–22.
- Ryu SI, Park YH, Kim J, Huh I, Chang SJ, Jang SN, et al. Impact of COVID-19 on the social relationships and mental health of older adults living alone: A two-year prospective cohort study. *PLoS One*. 2022;17(7), e0270260.
- Fullen MC, Shannnonhouse LR, Mize MC, Miskis C. Mental health distress in homebound older adults: importance of the aging network. *Ageing Ment Health*. 2021;25(8):1580–4.
- Alemi F, Avramovic S, Renshaw KD, Kanchi R, Schwartz M. Relative accuracy of social and medical determinants of suicide in electronic health records. *Health Serv Res*. 2020;55(Suppl 2):833–40.
- Van Orden KA, Driffill N, Stanley IH, Conwell Y. Social disconnectedness in primary care. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2013;21(3):S70.
- Vanderhorst RK, McLaren S. Social relationships as predictors of depression and suicidal ideation in older adults. *Ageing Ment Health*. 2005;9(6):517–25.
- Bernier S, Lapierre S, Desjardins S. Social interactions among older adults who wish for death. *Clin Gerontol*. 2020;43(1):4–16.
- Innamorati M, Pompili M, Di Vittorio C, Baratta S, Masotti V, Badaracco A, et al. Suicide in the old elderly: results from one Italian county. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2014;22(11):1158–67.
- Steptoe A, Shankar A, Demakakos P, Wardle J. Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2013;110(15):5797–801.
- Hernandez SC, Overholser JC, Philips KL, Lavacot J, Stockmeier CA. Suicide among older adults: Interactions among key risk factors. *Int J Psychiatry Med*. 2021;56(6):408–21.
- Cuperfain AB, Furqan Z, Sinyor M, Mulsant BH, Shulman K, Kurdyak P, et al. Qualitative analysis of suicide notes to understand suicidality in older adults. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2022;30(12):1330–8.

43. Wand APF, Peisah C, Draper B, Brodaty H. Why do the very old self-harm? A qualitative study. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2018 Aug;26(8):862–871. <https://doi.org/10.1016/j.jagp.2018.03.005> Epub 2018 Mar 15. Erratum in: *Am J Geriatr Psychiatry*. 2019 Feb;27(2):211.
44. Silva RMD, Sousa GS, Vieira IJES, Caldas JMP, Minayo MCS. Suicidal ideation and attempt of older women in Northeastern Brazil. *Rev Bras Enferm*. 2018;71(Suppl 2):755–62.
45. Huang LB, Tsai YF, Liu CY, Chen YJ. Influencing and protective factors of suicidal ideation among older adults. *Int J Ment Health Nurs*. 2017;26(2):191–9.
46. Lee SH, Tsai YF, Chen CY, Huang LB. Triggers of suicide ideation and protective factors of actually executing suicide among first onset cases in older psychiatric outpatients: a qualitative study. *BMC Psychiatry*. 2014(14):269.
47. Rubenowitz E, Waern M, Wilhelmson K, Allebeck P. Life events and psychosocial factors in elderly suicides—a case-control study. *Psychol Med*. 2001;31(7):1193–202.
48. Waern M, Rubenowitz E, Wilhelmson K. Predictors of suicide in the old elderly. *Gerontology*. 2003;49(5):328–34.
49. Hawton K, Harris L. Deliberate self-harm in people aged 60 years and over: characteristics and outcome of a 20-year cohort. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2006;21(6):572–81.
50. Harrison KE, Dombrowski AY, Morse JQ, Houck P, Schlermizauer M, Reynolds 3rd CF, et al. Alone? Perceived social support and chronic interpersonal difficulties in suicidal elders. *Int Psychogeriatr*. 2010;22(3):445–54.
51. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2021;74(9):790–9 English, Spanish. Erratum in: *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2022 Feb;75(2):192.
52. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP, STROBE Initiative. The Strengthening of Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *Int J Surg*. 2014;12(12):1495–9.
53. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savović J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ*. 2016(355), i4919.
54. Wells GA, Shea B, O'Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for Assessing the Quality of Nonrandomised Studies in Meta-Analyses [consultado 12 Dic 2022]. Disponible en: https://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp; 2014.
55. Lu L, Xu L, Luan X, Sun L, Li J, Qin W, et al. Gender difference in suicidal ideation and related factors among rural elderly: a cross-sectional study in Shandong, China. *Ann General Psychiatry*. 2020(19):2.
56. Yang Y, Wang R, Zhang D, Zhao X, Su Y. How loneliness worked on suicidal ideation among Chinese nursing home residents: roles of depressive symptoms and resilience. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(10):5472.
57. Wang R, Yang Y, Li Y, Liu Y, Zhao X, Jia J, et al. Social support moderates suicidal ideation among Chinese nursing home residents with limited activities of daily living and loneliness. *Arch Psychiatr Nurs*. 2021;35(6):638–44.
58. Li H, Xu L, Chi I. Factors related to Chinese older adults' suicidal thoughts and attempts. *Aging Ment Health*. 2016;20(7):752–61.
59. Kim J, Gwak D, Kim S, Gang M. Identifying the suicidal ideation risk group among older adults in rural areas: developing a predictive model using machine learning methods. *J Adv Nurs*. 2023;79(2):641–51.
60. Lutzman M, Sommerfeld E, Ben-David S. Loneliness and social integration as mediators between physical pain and suicidal ideation among elderly men. *Int Psychogeriatr*. 2021;33(5):453–9.
61. Cheung G, Edwards S, Sundram F. Death wishes among older people assessed for home support and long-term aged residential care. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2017;32(12):1371–80.
62. Lee S. Passive suicidal ideation in older adults from 12 European countries. *J Popul Ageing*. 2023;16(1):137–54.
63. Lee C, Cho B, Yang Q, Chang SJ, Ko H, Yi YM, et al. Psychosocial risk profiles among older adults living alone in South Korea: a latent profile analysis. *Arch Gerontol Geriatr*. 2021;95 104429.
64. Jonson M, Sigström R, Mellqvist Fässberg M, Wetterberg H, Rydén L, Rydberg Sterner T, et al. Passive and active suicidal ideation in Swedish 85-year-olds: time trends 1986–2015. *J Affect Disord*. 2021(290):300–7.
65. Stolz E, Fux B, Mayerl H, Rásky É, Freidl W. Passive suicide ideation among older adults in Europe: a multilevel regression analysis of individual and societal determinants in 12 countries (SHARE). *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*. 2016;71(5):947–58.
66. Solomonov N, Green J, Quintana A, Lin J, Ognyanova K, Santillana M, et al. A 50-state survey study of thoughts of suicide and social isolation among older adults in the United States. *J Affect Disord*. 2023(334):43–9.
67. Zhu RT, Ma ZY, Jia CX, Zhou L. Completed suicide with violent and non-violent methods by the elderly in rural China: a psychological autopsy study. *Front Psychiatry*. 2021;12, 624398.
68. Niu L, Jia C, Ma Z, Wang G, Sun B, Zhang D, et al. Loneliness, hopelessness and suicide in later life: a case-control psychological autopsy study in rural China. *Epidemiol Psychiatr Sci*. 2020;29, e119.
69. Wiktorsson S, Runeson B, Skoog I, Ostling S, Waern M. Attempted suicide in the elderly: characteristics of suicide attempters 70 years and older and a general population comparison group. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2010;18(1):57–67.
70. Hays RD, DiMatteo MR. A short-form measure of loneliness. *J Pers Assess*. 1987;51(1):69–81.
71. Russell D, Peplau LA, Cutrona CE. The revised UCLA Loneliness Scale: concurrent and discriminant validity evidence. *J Pers Soc Psychol*. 1980;39(3):472–80.
72. Hughes ME, Waite LJ, Hawkey LC, Cacioppo JT. A short scale for measuring loneliness in large surveys: results from two population-based studies. *Res Aging*. 2004;26(6):655–72.
73. Russell DW. UCLA Loneliness Scale (Version 3): reliability, validity, and factor structure. *J Pers Assess*. 1996;66(1):20–40.
74. Dahlem NW, Zimet GD, Walker RR. The multidimensional scale of perceived social support: a confirmation study. *J Clin Psychol*. 1991;47(6):756–61.
75. Lubben J, Blozik E, Gillmann G, Iliffe S, von Renteln Kruse W, Beck JC, et al. Performance of an abbreviated version of the Lubben Social Network Scale among three European community-dwelling older adult populations. *Gerontologist*. 2006;46(4):503–13.
76. Kim KH, Kim JH. Korea UCLA loneliness scale. *J Stud Guid*. 1989;16:13–30.
77. Mitchell PH, Powell L, Blumenthal J, Norten J, Ironson G, Pitula CR, et al. A short social support measure for patients recovering from myocardial infarction: the ENRICH Social Support Inventory. *J Cardpulm Rehabil*. 2003;23(6):398–403.
78. Zhou L, Li Z, Hu M, Xiao S. Reliability and validity of ULS-8 loneliness scale in elderly samples in a rural community. *Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban*. 2012;37(11):1124–8.
79. Koenig HG, Westlund RE, George LK, Hughes DC, Blazer DG, Hybels C. Abbreviating the Duke Social Support Index for use in chronically ill elderly individuals. *Psychosomatics*. 1993;34(1):61–9.
80. Beck AT, Kovacs M, Weissman A. Assessment of suicidal intention: the scale for suicide ideation. *J Consult Clin Psychol*. 1979;47(2):343–52.
81. Li X-Y, Phillips MR, Zhang YL, Xu D, Tong Y-S, Yang F-D, et al. Reliability and validity of the Chinese version of Beck Scale for suicide ideation (BSI-CV) among university students. *Chin Ment Health J*. 2011;25(11):862–6.
82. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. *J Gen Intern Med*. 2001;16(9):606–13.
83. Beck AT, Steer RA, Ranieri WF. Scale for Suicide Ideation: psychometric properties of a self-report version. *J Clin Psychol*. 1988;44(4):499–505.
84. Zhang J, Jia CX. Validating a short version of the Suicide Intent Scale in China. *Omega (Westport)*. 2007;55(4):255–65.
85. Paykel ES, Myers JK, Lindenthal JJ, Tanner J. Suicidal feelings in the general population: a prevalence study. *Br J Psychiatry*. 1974;124(0):460–9.
86. McClelland H, Evans JJ, Nowland R, Ferguson E, O'Connor RC. Loneliness as a predictor of suicidal ideation and behaviour: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *J Affect Disord*. 2020(274):880–96.
87. Van Orden KA, Witte TK, Cukrowicz KC, Braithwaite SR, Selby EA, Joiner Jr TE. The interpersonal theory of suicide. *Psychol Rev*. 2010;117(2):575–600.
88. Baumeister RF, Leary MR. The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. *Psychol Bull*. 1995;117(3):497–529.
89. Durkheim E. *Le Suicide: Etude de Sociologie*. Paris: F. Alcan; 1897. [Translated by Spaulding JA, Simpson G. *Suicide: A Study in Sociology*. Glencoe, IL: Free Press; 1951.] 2nd ed. London: Routledge; 2005.
90. O'Connor RC, Kirtley OJ. The integrated motivational-volitional model of suicidal behaviour. *Philos Trans R Soc Lond Ser B Biol Sci*. 2018;373(1754), 20170268.
91. Manterola C, Astudillo P, Arias E, Claros N, Grupo MINCIR (Metodología e Investigación en Cirugía). Revisión sistemática de la literatura. Qué se debe saber acerca de ellas [Systematic reviews of the literature: what should be known about them]. *Cir Esp*. 2013;91(3):149–55.
92. Asberg M, Montgomery SA, Perris C, Schalling D, Sedvall G. A comprehensive psychopathological rating scale. *Acta Psychiatr Scand Suppl*. 1978;271:5–27.